高橋　冴愛　様

2025年度　モニタリング記録

管理者	サビ管	作成者

実施日	2025年11月10日
参加者	高橋冴愛様・仁木サビ管・中村
計画実施期間	2024年12月2日～2025年11月30日
次回モニタリング時期	2026年3月

モニタリング実施者（サービス管理責任者）

仁木芳典・中村正明

No.	目標/留意点	課題の実行・対応の状況	今後の課題	継続または変更
1	日常生活を安心して楽しく過ごし、生活介護（通所）を安定して継続する。	職員との関わりは概ね良好で、日中はテレビ視聴（ドラえもん・AKB等）や折り紙など、本人が選べる活動がある日は落ち着いて過ごせている。 生活介護（大地）については「通所は好き」との意向があり、基本的には通所できている。 一方で、刺激（周囲の発言・特定職員へのこだわり等がきっかけとなる日は、独語が増え、興奮が上がりやすい。興奮が上がると、玄関・エレベーターへ向かう行動が続き、職員がマンツーマンで対応する場面がある。 不穏が強い日は、帰宅後にロビーで床へ頭を打ち付ける等の自傷が出現し、環境調整（自室誘導・刺激遮断）が必要となった記録がある。	日中活動は「本人が選べるメニュー」を固定化し、毎日必ず提示する（例：①動画10分 ②折り紙 ③塗り絵 ④食器洗い ⑤短時間散歩）ことで、外出執着・エレベーター行動が始まる前に代替行動へ切り替える。 通所前後は不穏が上がりやすいため、帰宅直後のルーティン（荷物→水分→着替え→落ち着く場所）を統一し、落ち着いた状態で夕方を過ごせる導線を作る。 通所先へは、ホームで頓服を使用した場合に限り、薬剤名・時刻・理由を連絡帳に記載し、日中の対応を合わせる。	継続
2	栄養バランスの良い食事を安全に摂り、キッチン立ち入り（配膳前侵入）をなくす。	夕食を「早く食べたい」気持ちが強い日に、配膳前にキッチンへ入ろうとする行動が継続して見られる。 職員の声かけで退室できる場面はあるが、衛生・安全上、キッチンへの侵入は継続してリスクとなっている。 興奮が上がった場面では、配膳物を床へ投げる等が起こり、食事場面の安全確保が課題となる。 食事量は多く（お替わり傾向）、間食（しょっぱいお菓子）も好むため、体重・健康管理の観点で継続的な把握が必要。	配膳前は、職員が必ず本人へ 「席で待つ→手洗い→配膳→いただきます」を短文で同じ順に伝える（職員全員で言い方を統一）。 キッチン侵入が始まったら、①入口で止める（身体でブロックではなく“立ち位置で動線を切る”）②席へ誘導③待てたら即時に褒めるを徹底する。 興奮兆候（独語増・大声・机を叩く等）が出たら、一旦配膳を下げ、落ち着いてから再提示して、投げる行為を起こさせない。 体重は月1回測定し、食事量・間食量は週単位で記録する。増加傾向があれば家族・訪看へ共有する。	継続
3	ホームルールを守り、夜間の不穏・自傷（頭打ち等）を早期に鎮静化して安全に過ごす。	夜間に精神的に不安定になり、独語増加から 床に頭を打ち付ける自傷が出現することがある。 不穏が強い時は、頓服（例：リスペリドン1mg、ジアゼパム5mg等）を使用し、自室誘導・刺激遮断で鎮静化を図った実績がある。 ただし、不穏の強さによっては、ロビーでの自傷が続き、マンツーマン対応が必要となる。 転倒や物投げ等により、他利用者への影響が発生した記録もあり、ホーム内安全の観点で早期介入が必須。	不穏対応は、①安全確保（他利用者と距離確保・危険物撤去）②刺激遮断（自室へ誘導）③短文での声かけ（否定・叱責をしない）の順で統一する。 頓服を使用した場合は、薬剤名・時刻・使用理由・使用後15～60分の変化を必ず記録し、頻回化する場合は 早期受診（西熊谷病院）を検討する。 PMSの影響が疑われる期間は、夜間の不穏が出やすいため、就寝前の声掛け回数を増やし、落ち着ける活動（動画・塗り絵等）を就寝ルーティンに組み込む。 就寝環境は、安全確保のため マットレス床置き＋周囲クッションを継続し、頭打ちが始まった時点で即介入する。	継続

特記事項	本人は「楽しく過ごしたい」「通所は好き」との意向が確認できた。不穏時は独語増加から自傷（床へ頭打ち）に移行しやすく、夕食前後・帰宅直後・夜間帯は特に注意が必要。キッチン立ち入りは継続して課題であり、衛生・安全上、職員の統一対応が必要。頓服使用時は、通所側が必要な情報（薬剤名・時刻）を把握できるよう、連絡帳への転記を徹底する。
会議報告	2025年11月10日、本人・仁木サビ管・中村でモニタリングを実施。生活介護の継続と、日中の楽しみ（動画・折り紙等）を軸に、安定した生活を継続する方針を確認。 キッチン立ち入りについては、配膳前手順の統一（席で待つ→手洗い→配膳）と、侵入時の誘導手順を職員間で統一することを確認。 夜間不穏・自傷については、刺激遮断と安全確保を優先し、頓服使用時の記録と医療連携（訪看・受診判断）を継続することを確認。